

PHASE 0 — SCOPE ĐÃ CHỐT · GATE 0

Dự án: MedTriage AI — AI agent trò chuyện với bệnh nhân ở hàng chờ cấp cứu để thu thập triệu chứng, phát hiện red flag và sinh phiếu bàn giao SBAR cho điều dưỡng. AI để xuất — điều dưỡng ký và quyết định. Mô hình B2B, khách hàng là bệnh viện. • Mục tiêu 1–3 tháng: qua cổng gác ngày 30 (27/09/2026) — đo containment ≥70% trên ≥800 ca hoàn tất thật tại một khoa cấp cứu, tức thay con số ước tính 78% bằng số đo. • Người tổng hợp: Lê Hoàng Việt. • Format: Markdown + HTML → PDF trên GitHub repo chung của nhóm.

1. STAKEHOLDER MAP — INFLUENCE × INTEREST (10 STAKEHOLDER)

	INTEREST THẤP	INTEREST CAO
INFLUENCE CAO	BLOCKER giữ hài lòng, xử lý mối lo - S2 · Ban Giám đốc + Phòng Tài chính–Kế toán BV A — người ký hợp đồng và duyệt ngân sách Chưa ủng hộ - S4 · Trưởng phòng CNTT / quản trị HIS BV A — chủ HL7, chủ VPC, chủ dữ liệu bệnh nhân Chưa ủng hộ - S9 · Hội đồng Quản lý chất lượng & đạo đức BV A — duyệt mọi thử nghiệm chạm tới người bệnh Trung lập - S7 · Nhà cung cấp HIS đương nhiệm của BV A — vừa là cửa tích hợp, vừa là kênh phân phối Plan B Trung lập	CHAMPION làm việc chặt chẽ, tận dụng sự ủng hộ - S1 · Trưởng khoa Cấp cứu BV A — người duy nhất cho phép sản phẩm xuất hiện trong khoa Trung lập ⚠ lệch nhãn - S5 · Giảng viên / mentor Track 1 — review dự án liên tục từ Day 22 đến Day 27, là cửa giới thiệu bệnh viện Ủng hộ
INFLUENCE THẤP	BYSTANDER chỉ theo dõi S10 · Quý ương tạo / nhà đầu tư thiên thần — nhóm chưa gọi vốn ở giai đoạn này, nên đây là stakeholder thật nhưng hiện chưa có ảnh hưởng lẫn quan tâm. Chỉ theo dõi, không tốn thời gian trước cổng gác ngày 90 Trung lập	SUPPORTER giữ thông tin, khai thác feedback - S3 · Điều dưỡng tiếp nhận (triage nurse) — người dùng thật, người ký phiếu SBAR Chưa ủng hộ ⚠ lệch nhãn - S8 · Bệnh nhân & người nhà ở hàng chờ — người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi kết quả phân loại Trung lập - S6 · Cố vấn tài chính ngoài công ty — người ngoài đội đã nhận dự cổng gác ngày 90 Ủng hộ

HAI CHỖ STANCE THỰC TẾ KHÔNG KHỚP NHẪN QUADRANT — NHÓM GHI THEO THỰC TẾ, KHÔNG GHI THEO NHẪN

S1 nằm ở Champion vì ảnh hưởng cao và quan tâm cao, nhưng stance thật là Trung lập: đến 29/08/2026 nhóm chưa có một chữ ký hay một email đồng ý nào. Gọi S1 là champion lúc này là tự trấn an, và sẽ dẫn tới việc bỏ qua bước thuyết phục. • S3 nằm ở Supporter, nhưng stance thật là Chưa ủng hộ: điều dưỡng tiếp nhận lo bị thay thế và lo phải làm thêm thao tác giữa ca trực quá tải. Nhân "influence thấp" chỉ đúng trên bản ký kết — trên thực địa S3 có quyền phủ quyết tuyệt đối, vì theo quy định hành nghề, phiếu SBAR không có giá trị nếu điều dưỡng không ký.

2. BỐN STAKEHOLDER ƯU TIÊN & CHIẾN LƯỢC 1–2 TUẦN TỚI

Stakeholder	Họ quan tâm điều gì?	Họ giúp hoặc cản dự án thế nào?	Hành động cụ thể (owner · deadline)
S5 · Giảng viên / mentor Track 1 Ủng hộ Tận dụng	Nhóm có dám mang mô hình ra thực địa hay chỉ dừng ở tài liệu đẹp; số liệu có trung thực không.	Giúp: review bản đề nghị trước khi nhóm gửi bệnh viện, và giới thiệu một khoa cấp cứu có thể nhận pilot. Cản: nếu thấy nhóm hứa vượt bằng chứng, mentor sẽ ngừng giới thiệu — mà đây là cửa vào bệnh viện duy nhất nhóm đang có.	Gửi mentor bản đề nghị shadow 1 trang + dashboard 8 đèn của Day 26 (giữ nguyên 4/8 đèn ghi "chưa đo", không tô hồng), xin 20 phút review và xin giới thiệu 1 khoa cấp cứu. → Việt · gửi 01/09 · họp xong trước 05/09/2026
S6 · Cố vấn tài chính ngoài công ty Ủng hộ Tận dụng	Mô hình kinh tế có chịu nổi số đo thật địa hay chỉ dừng ở tài liệu CAC giữa Day 24 (60 tr đ) và Day 25 (12.000 \$) — chênh 5,2 lần.	Giúp: là người ngoài duy nhất đã nhận dự cổng gác — chính là thứ chặn nhóm vừa đặt ngưỡng vừa tự báo cáo số. Cản: nếu không chốt lịch ngay, cổng gác lại chỉ còn ba người trong nhóm ngồi với nhau.	Chốt lịch cứng cho 3 cổng gác 27/09 · 27/10 · 26/11 và gửi trước một câu hỏi phản biện: "nếu containment thật rơi về 70% thì cắt gì đầu tiên?". → Việt · lịch chốt trước 08/09/2026
S1 · Trưởng khoa Cấp cứu BV A Chưa ủng hộ Thuyết phục	Không làm chậm hàng chờ, không tăng việc cho điều dưỡng, không phát sinh rủi ro pháp lý cho khoa.	Giúp: chữ ký của S1 là thứ duy nhất mở được 800 ca thật cho cổng gác ngày 30. Cản: S1 nói không thì toàn bộ mốc 27/09 đổ, và hiện nhóm không có bệnh viện B nào đang chờ.	Gửi đề nghị shadow mode 2 tuần, ca trực ngày 7h–15h: AI không hiển thị bậc ưu tiên cho bất kỳ ai, chỉ sinh SBAR song song để khoa đối chiếu. Không hợp đồng · không nối HIS · không ngân sách. Xin 45 phút với điều dưỡng trưởng ca để chốt luồng. → Việt · gửi 03/09 · chốt ngày bắt đầu trước 12/09/2026
S3 · Điều dưỡng tiếp nhận Chưa ủng hộ Thuyết phục	Ca trực đã quá tải; sợ bị thay thế; sợ phải ký một phiếu do máy viết mà mình không kiểm được.	Giúp: là người duy nhất chốt được nhãn đúng cho bộ eval — đúng thứ nhóm đang thiếu hoàn toàn. Cản: chỉ cần không ký SBAR là containment về 0, dù model tốt đến đâu.	Mời 1 điều dưỡng trưởng ca làm người chốt nhãn cho 30 golden cases, trả công theo buổi, tên được ghi trong tài liệu eval. Đổi vai từ "người bị thay thế" thành "người ra đề cho AI". → Linh · buổi gặp nhãn đầu tiên trước 12/09/2026

VÌ SAO CHỌN ĐÚNG BỐN NGƯỜI NÀY MÀ KHÔNG PHẢI S2 HAY S4

S2 (ký hợp đồng) và S4 (mở HL7) đều là Blocker ảnh hưởng cao, nhưng cả hai chỉ chặn giai đoạn sau shadow. Đề nghị ở trên được thiết kế để không cần chữ ký của S2 và không cần S4 mở HL7: nhóm dùng kiosk nhập tay đặt ở hàng chờ, dữ liệu khứ PII trước khi rời VPC bệnh viện. Kéo S2 và S4 vào hai tuần này là tự dựng thêm hai cửa phải xin phép trước khi có bất kỳ con số nào để nói. S4 được kích hoạt ngay sau cổng gác ngày 30 — xem Trang 3, capability gap G-2.

1. PITCH — CONCLUSION FIRST

KẾT LUẬN	Đề nghị khoa cho MedTriage AI chạy shadow mode 2 tuần, ca trực ngày 7h–15h, mục tiêu 200 ca. AI không hiển thị bậc ưu tiên cho bất kỳ ai; nó chỉ sinh phiếu SBAR song song để khoa đối chiếu sau ca trực. Không đối quy trình tiếp nhận, không nối vào HIS, không cần chữ ký của phòng tài chính và không tốn ngân sách của khoa.
LÝ DO 1	Nút thắt của khoa nằm ở thời gian tiếp nhận, không nằm ở quyết định lâm sàng. MedTriage chỉ nhận đúng phần trước quyết định: hỏi triệu chứng, soi red flag, viết SBAR. Điều dưỡng vẫn là người ký và người quyết định — ranh giới này nhóm đã chốt từ Day 22 và không đổi.
LÝ DO 2	Shadow mode làm rủi ro lâm sàng của hai tuần này bằng 0 theo thiết kế, chứ không bằng lời hứa: đầu ra của AI không đi tới người ra quyết định, nên không tồn tại đường nào để AI gây under-triage trong giai đoạn đo.
LÝ DO 3	Khoa nhận được thứ hiện chưa ai có: 200 ca đo thật về tỉ lệ thông tin AI thu đủ (containment) và tỉ lệ bỏ sót dấu hiệu nặng (under-triage) của chính khoa mình — và giữ được số đó kể cả khi khoa quyết định dừng.
BẰNG CHỨNG	Có thật: mô hình kinh tế đã dựng đủ và kiểm chứng ngược bằng script — 22/22 phép kiểm tra khớp (workbook Day 25 + verify_thresholds.py Day 26): giá 6.000.000 đ/tháng + 13.000 đ/ca, chi phí AI 2.307 đ/ca, gross margin mô hình 71,8%, breakeven containment 55,1%. Luật an toàn viết trước khi chạy: R-03 — under-triage >3,0% trong 1 tuần đo thì tắt đề xuất bậc ưu tiên trong 24h; cổng ngày 30 có ý là cổng học, không gắn doanh thu. Điều nhóm CHƯA có, nói trước: containment 78% là ước tính dựng từ dưới lên, chưa từng đo trên ca thật; 4/8 đèn dashboard đang ghi "chưa đo"; sản phẩm chưa chạy ca thật nào. Chính vì vậy đề nghị là shadow mode, không phải triển khai.
SMALL ASK	Xin đúng hai thứ: (1) 45 phút với một điều dưỡng trưởng ca để chốt luồng đặt kiosk ở hàng chờ; (2) chữ ký đồng ý cho 2 tuần shadow ở ca trực ngày, bắt đầu 15/09/2026. Không hợp đồng, không tài khoản HIS, không thay đổi phần mềm của khoa.

2. PHẢN BIỆN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA NHẤT — VÀ CÁCH XỬ LÝ

PHẢN BIỆN "AI chưa đủ đáng tin để dựng vào bệnh nhân cấp cứu. Nếu nó bỏ sót một ca nặng thì ai chịu trách nhiệm?" Đây là phản biện nhóm chọn vì nó đúng và vì nhóm không có số đo nào để bác lại — mọi câu trả lời phải dựa vào thiết kế và vào luật dừng, không dựa vào ý kiến.	TRẢ LỜI — BẰNG CHỨNG & HÀNH ĐỘNG GIẢM RỦI RO - Trong 2 tuần shadow, không có đường nào để AI gây under-triage — đầu ra không tới người ra quyết định. Rủi ro cần bàn là rủi ro sau shadow; nhóm đề nghị đo nó trước rồi mới bàn. - Trách nhiệm pháp lý không đổi: phiếu SBAR chỉ có giá trị khi điều dưỡng ký. Đây là ràng buộc nhóm tự đặt từ Day 22, cùng với kết luận conditional-go và 5 release blocker chưa gỡ. - Có luật dừng viết sẵn, không phải viết sau khi có sự cố: R-03 (under-triage >3,0% → tắt đề xuất bậc ưu tiên trong 24h) và R-02 (containment <55,1% ba tuần liên tiếp → dừng toàn bộ bán hàng 30 ngày). - Số đo do khoa giữ. Nếu khoa dừng ở bất kỳ ngày nào, nhóm bàn giao toàn bộ ca đã gán nhãn cho khoa và không giữ bản sao có PII. - Nhóm không xin niềm tin, nhóm xin 200 ca để thay ước tính bằng số đo.
--	---

3. RACI MATRIX — 6 CÔNG VIỆC QUAN TRỌNG CỦA 1–2 THÁNG TỚI

Công việc (1–2 tháng tới)	Việt AI Product Owner	Linh Clinical Safety & Evals	Hưng AI / Platform Eng	S5 Mentor	S1 Trưởng khoa CC	S4 CNTT / HIS	Ghi chú — vì sao A là người này
T1. Chốt phạm vi shadow pilot & thuyết phục BV A (gửi đề nghị, họp điều dưỡng trưởng, lấy đồng ý)	A R	C	I	C	C	I	Việt là người duy nhất có quan hệ với S1 và S5. Đội 3 người nên R ≡ A ở việc đối ngoại; bù lại mentor là C bắt buộc trước khi bàn đề nghị được gửi đi.
T2. Dựng kiosk nhập liệu tay ở hàng chờ + pipeline khử PII trong VPC bệnh viện	I	C	A R	I	I	C	Nếu dữ liệu rơi VPC mà chưa khử PII thì hỏng cả pilot lẫn quan hệ với S4. Hưng là người viết đường dữ liệu nên chịu trách nhiệm cuối.
T3. Chuẩn bị dữ liệu: 30 golden cases có nhãn do người hành nghề y chốt + bộ nhãn 420 ca	C	A	R	I	C	I	R và A tách: Hưng dựng bộ dữ liệu và công cụ gán nhãn, Linh chịu trách nhiệm cuối về nhãn có đúng lâm sàng không.
T4. Kiểm thử an toàn: đo under-triage & containment, chạy eval trước mỗi lần release	I	A	R	C	C	I	R và A tách: Hưng chạy eval harness, Linh chịu trách nhiệm cuối về ngưỡng an toàn và về việc kích hoạt R-03.
T5. Vận hành shadow pilot 2 tuần tại khoa (uptime kiosk, thu ca, trực hỗ trợ tại chỗ)	R	R	A	I	C	I	Cả ba cùng trực, nhưng chỉ một người chịu trách nhiệm cuối nếu ca bị mất hoặc kiosk chết giữa ca — đó là người sở hữu hạ tầng.
T6. Quyết định GO / FIX tại cổng gác ngày 30 (27/09/2026) và kích hoạt luật dừng R-02 / R-03 nếu chạm ngưỡng	A R	C	C	C	C	I	Quyết định release thuộc về người sở hữu mô hình kinh tế và cổng gác. Bắt buộc có người ngoài đội dự (S5 hoặc S6) để chống tự chấm tự duyệt.

Kiểm tra RACI 6/6 hàng có đúng 1 A, không hàng nào hai A, không hàng nào thiếu A. • Phân bố A cân: Việt T1+T6 (đối ngoại và quyết định) · Linh T3+T4 (an toàn lâm sàng) · Hưng T2+T5 (hạ tầng và vận hành) — không dồn hết A về trưởng nhóm. • Tách được R khỏi A ở 3/6 hàng (T3, T4, T5). Ba hàng còn lại để R ≡ A vì đội chỉ có 3 người và việc đó thực tế chỉ một người làm được — đúng rule-of-thumb "team rất nhỏ thì một người có thể vừa R vừa A"; nhóm bù bằng cách bắt buộc có C là người ngoài đội ở cả T1 và T6, để không có việc nào vừa tự làm vừa tự duyệt kín. • Nối với Trang 1: S1, S4, S5 — ba stakeholder ưu tiên và Blocker của Trang 1 — đều là cột thật trong ma trận này, không phải tên nhắc cho dù.

1. TEAM ARCHITECTURE — CHỌN EMBEDDED

Mô hình	Bản chất	Chọn?	Lý do với quy mô và giai đoạn hiện tại
Centralized	Một nhóm AI trung tâm phục vụ nhiều sản phẩm / nhiều team	Không	Nhóm chỉ có một sản phẩm . Một hub trung tâm phục vụ đúng một team là chi phí điều phối không đổi lấy gì.
Hybrid	Có hub AI chung, đồng thời có người AI nhúng vào từng team sản phẩm	Chưa	Hybrid chỉ có nghĩa khi có năng lực <i>dùng lại được</i> giữa nhiều nơi. Nhóm sẽ chuyển sang Hybrid khi đạt ≥3 bệnh viện và ≥6 người — lúc đó tách hub cho eval và connector HL7 dùng lại được (đúng nhánh hành động của luật R-05).
Embedded	Năng lực AI nằm trực tiếp trong team sản phẩm	CHỌN	Cả ba người đều phải đứng cạnh chính use case . Ở sản phẩm này, quyết định khó nhất — "thế nào là một red flag" — không tách rời khỏi lâm sàng, nên không thể đẩy sang một hub ở xa. Với 3 người và một khoa cấp cứu, mọi lớp trung gian đều làm chậm vòng học.

2. CORE ROLES — VAI TRÒ CẦN NGAY Ở GIAI ĐOẠN NÀY

Core Role	AI đảm nhiệm	Sở hữu cái gì	Vì sao cần ngay (không phải "có thì tốt")
AI Product Owner / Founder	Lê Hoàng Việt 2A202601543	Mô hình kinh tế, 3 cổng gác, quan hệ stakeholder, quyết định release	Cổng gác ngày 30/60/90 và quyết định GO/FIX/KILL phải có một người chịu trách nhiệm cuối . Nếu không, luật dừng sẽ không bao giờ được ai bấm.
Clinical Safety & Evals Lead	Hồ Phạm Đức Linh 2A202601533	Định nghĩa red flag, bộ golden cases, ngưỡng under-triage, quyền bấm R-03	Không đo được under-triage thì không được phép chạm tới bệnh nhân . Đây là release blocker số 1 còn lại từ Day 22, và là đèn L-03 đang ghi "chưa đo".
AI / Platform Engineer	Trần Vương Hưng 2A202601789	Kiosk, VPC, khử PII, pipeline dữ liệu, eval harness, uptime pilot	Không có đường dữ liệu chạy được thì không tồn tại ca nào để đo — cổng ngày 30 không có input.
Domain Expert lâm sàng CHƯA CÓ	Trống — đây là gap G-1	Chốt phác đồ ưu tiên, định nghĩa red flag, ký nhận nhận của bộ eval	Không ai trong ba người là người hành nghề y . Nhấn do người không hành nghề chốt thì bộ eval không có giá trị, và cổng ngày 30 sẽ đo bằng thước đo chính nhóm tự đức.

EXTENDED — VAI TRÒ ĐỂ DÀNH, CỐ Ý CHƯA LẬP BÂY GIỜ

Forward Deployed Engineer (mở khi ≥3 bệnh viện chạy song song) · MLOps / Evals chuyên trách (khi eval phải chạy hằng ngày trên nhiều phiên bản) · Legal / Compliance dữ liệu y tế (khi ký hợp đồng thật với S2, không cần cho shadow) · UX cho kiosk tiếng Việt, người cao tuổi (khi containment đã được đo và trở thành thứ cần tối ưu). Nguyên tắc nhóm tự đặt: mỗi chức danh thêm vào phải trả lời được câu "nó gỡ blocker nào của cổng gác gần nhất?" — bốn vai trò trên đều không gỡ được cổng ngày 30, nên chưa lập.

3. PRIORITY RESOURCING — BA CAPABILITY GAP QUAN TRỌNG NHẤT

Capability gap	Cách bổ sung	Vì sao chọn cách này	Khi nào cần
G-1 · Chuyên môn lâm sàng cấp cứu chốt red flag, phác đồ ưu tiên và nhận đúng cho 30 golden cases	PARTNER Thỏa thuận cố vấn với 1 điều dưỡng trưởng + 1 bác sĩ khoa cấp cứu BV A, trả công theo buổi gần nhân	Ở giai đoạn MVP nhóm không có tiền và cũng không có việc full-time cho một bác sĩ — Hire là sai kích cỡ. Outsource cho một đơn vị y tế ngoài cũng sai, vì người chốt nhãn nên là người của chính khoa sẽ dùng sản phẩm : cùng phác đồ, cùng loại bệnh nhân, cùng áp lực ca trực. Partner ở đây lấp gap và đồng thời chuyển S1/S3 từ trung lập thành người trong cuộc — một hành động giải quyết hai việc (xem Trang 1).	Trước shadow pilot hạn 12/09/2026 Không có G-1 thì T3 không khởi động được
G-2 · Tích hợp HL7 / HIS và bảo mật dữ liệu bệnh viện connector và mức khử PII đạt yêu cầu phòng CNTT	OUTSOURCE Thuê 1 kỹ sư tích hợp HL7 theo gói cho phần connector; Hưng giữ quyền review và nhóm giữ quyền sở hữu mã	Đây là năng lực dùng theo đợt chứ không liên tục : nối xong một bệnh viện thì gần như không đụng tới cho đến bệnh viện sau. Tuyển full-time sẽ đẩy chi phí triển khai ÷ ACV vượt trần 24,4% (phép tính MH-03) — đúng con số mà cổng ngày 60 đang gác. Partner với nhà cung cấp HIS (S7) là lựa chọn thứ hai, nhưng làm nhóm mất quyền chủ động về lịch. Giữ quyền sở hữu mã để lần thứ hai rẻ hơn lần thứ nhất .	Sau cổng ngày 30, trước cổng ngày 60 (27/10/2026) Shadow pilot cố ý thiết kế để không cần HIS
G-3 · Evals / quality evaluation có kỷ luật bộ golden cases, chạy eval mỗi release, đo under-triage & over-triage	PARTNER — chỉ cho vòng thẩm định độc lập Không Hire, không Outsource phần chạy eval hằng ngày — nâng nội bộ (Linh)	Đây là năng lực lõi, thuê ngoài là tự bịt mắt mình . Nếu người ngoài chạy eval, đội mất luôn khả năng tự biết mình sai ở đâu và mất phản xạ bấm luật dừng. Cái phải đến từ bên ngoài chỉ là tính độc lập của người chấm — nên Partner đúng một việc: mentor (S5) và cố vấn tài chính (S6) dự cổng gác với tư cách người ngoài đội. Phần năng lực còn lại nâng nội bộ, và đó chính là hành động G-2 của Growth Plan Trang 4 .	Bộ eval chạy được trước 19/09/2026 ; vòng thẩm định độc lập trước cổng ngày 90 (26/11/2026)

4. SQUAD GOAL

"Squad MedTriage của chúng tôi sở hữu **toàn bộ đường đi của một ca cấp cứu, từ lúc bệnh nhân ngồi xuống hàng chờ đến lúc điều dưỡng ký phiếu SBAR, và chịu trách nhiệm đưa tỉ lệ containment cùng tỉ lệ under-triage từ ước tính dựng trên giấy (78% / chưa đo) đến số đo trên ≥800 ca thật tại một khoa cấp cứu, trước 27/09/2026.**"

NHÓM CỐ Ý KHÔNG LÀM GÌ Ở TRANG NÀY

Không thêm chức danh nào cho đẹp tổ chức đồ. Ba người giữ đúng ba vai, vai thứ tư **bỏ trống và gọi tên đúng là gap** thay vì chia nhau gánh rồi coi như đã có. Cũng không viết "cần tuyển thêm người": trong ba gap thì **không gap nào được giải bằng Hire** ở giai đoạn này — hai gap dùng Partner, một gap dùng Outsource theo gói, và phần lõi thì nâng nội bộ.

1. TEAM HEALTH — MỖI NGƯỜI TỰ CHẤM 1–5, CHẤM RIÊNG TRƯỚC KHI SO

Khía cạnh	Việt	Linh	Hưng	Trung bình	Chênh	
Chất lượng AI output đủ tốt và ổn định chưa?	4	2	3	3,0	2 ▮	
Tiến độ có làm đúng cam kết không?	4	3	3	3,3	1	
Tinh thần team dám nói vấn đề, phối hợp tốt?	4	4	5	4,3	1	
Tốc độ ra sản phẩm bao lâu để user thử được một thay đổi?	2	2	3	2,3 ↓	1	

KHÍA CẠNH THẤP NHẤT — TỐC ĐỘ RA SẢN PHẨM (2,3/5)

Cả ba chấm thấp vì cùng một sự thật: **đến hôm nay sản phẩm chưa chạy một ca thật nào**. Mọi thay đổi của 5 ngày qua chỉ đi từ tài liệu này sang tài liệu khác. Với sản phẩm này, "tốc độ ra sản phẩm" phải đo bằng **số ngày từ một thay đổi đến một ca cấp cứu thật dùng nó** — hiện là **vô hạn**.

CHÊNH LỆCH LỚN NHẤT — CHẤT LƯỢNG AI: VIỆT 4 VS LINH 2

Hỏi ra thì hai người **đang chấm hai thứ khác nhau**. **Việt chấm 4** vì nhìn chất lượng *bản thiết kế*: mô hình kinh tế kiểm chứng ngược 22/22, dashboard 8 đèn đủ ngưỡng, 4 luật dừng. **Linh chấm 2** vì nhìn chất lượng *đầu ra lâm sàng*: chưa có bộ eval nào, chưa ca thật nào, under-triage chưa đo. **Cả hai đều đúng về thứ mình nhìn — và đó mới là vấn đề: đội đang nhầm "tài liệu chặt" với "sản phẩm tốt"**. Đây là phát hiện quan trọng nhất của Phase 4, và nó khớp đúng điểm yếu nhóm đã tự ghi ở Day 26: *"dashboard của một sản phẩm chưa chạy ca thật nào"*.

VẤN ĐỀ ƯU TIÊN — NẾU KHÔNG XỬ LÝ SẼ TRỰC TIẾP LÀM HỒNG MILESTONE TIẾP THEO

Đội không có đường đo chất lượng đầu ra, nên tốc độ ra sản phẩm đang bằng 0 ca thật. Cổng gác ngày 30 (27/09/2026) đòi **≥800 ca hoàn tất** với containment **≥70%**. Hôm nay 29/08 nhóm chưa có ca nào, chưa có bộ eval, chưa có chữ ký cho shadow pilot — **còn 29 ngày**. **Nói thẳng một rủi ro**: nếu shadow bắt đầu 15/09 thì chỉ còn 12 ngày thu ca, tức cần ~67 ca/ngày. Nhóm **không** xử lý bằng cách nới định nghĩa "ca hoàn tất" cho số đẹp hơn; nhóm sẽ **báo cáo lại quy mô mẫu thật tại cổng** và chấp nhận kết luận FIX nếu mẫu chưa đủ — đúng nguyên tắc đã tự đặt ở Day 26: không nới định nghĩa, không giảm giá, không tuyển thêm sales để đẩy vào một phiếu đang tắc.

2. COMPETENCY CẦN NÂNG — DỪNG KHUNG L1 / L2 / L3

Role được chọn	Mức hiện tại (gần nhất)	Competency cần nâng tiếp theo	Hành động thực hành trong 30 ngày
Clinical Safety & Evals Lead Hồ Phạm Đức Linh	Gần L2 — AI Practitioner Bằng chứng: ở Day 22 đã tự dựng harm map 10 dòng đủ 7 failure layer, 8 gap và 5 release blocker cho một copilot chẩn đoán — nhưng chưa từng chạy một eval có số .	Evals / quality evaluation Chuyển từ "biết rủi ro nằm ở đâu" sang "đo được rủi ro đó bằng số, lặp lại được".	Xây bộ 30 golden cases có nhãn do điều dưỡng trưởng BV A chốt và ký nhận; dựng lệnh một dòng chạy eval trước mỗi lần release; xuất bảng under-triage / over-triage theo từng lần chạy. Đạt đủ L2 và mở đường lên L3 — AI Builder khi bộ eval trở thành công chặn release chứ không phải báo cáo tham khảo.

3. GROWTH PLAN 30 NGÀY — TỐI ĐA 3 HÀNH ĐỘNG (29/08 → 28/09/2026)

Vấn đề	Hành động 30 ngày	Owner	Deadline	Dấu hiệu hoàn thành (kiểm được)
G-1 . Chưa có chữ ký nào cho ca thật → tốc độ ra sản phẩm 2,3/5 và cổng ngày 30 không có input	Gửi bản đề nghị shadow 1 trang cho Trưởng khoa Cấp cứu BV A (mentor review trước khi gửi), họp 45 phút với điều dưỡng trưởng ca, chốt ngày bắt đầu và ca trực. Nếu bị từ chối, gửi tiếp bệnh viện thứ hai trong cùng tuần thay vì chờ.	Lê Hoàng Việt = A của T1 trong RACI	Gửi 03/09 Chốt ngày bắt đầu 12/09/2026	Có email hoặc biên bản đồng ý ghi rõ ngày bắt đầu và ca trực . Nếu bị từ chối: có văn bản lý do và tên bệnh viện thứ hai đã gửi đề nghị.
G-2 . Chênh 2 điểm về "chất lượng AI" vì không ai trong đội đo được đầu ra lâm sàng	Xây 30 golden cases (nhân do điều dưỡng trưởng BV A chốt và ký nhận), dựng lệnh make eval chạy trước mỗi lần release, báo cáo tỉ lệ under-triage / over-triage sau mỗi lần chạy.	Hồ Phạm Đức Linh = A của T3 và T4 trong RACI	19/09/2026 trước cổng ngày 30 đúng 8 ngày	make eval1 chạy được trên máy của cả ba người và in ra bảng 30 ca kèm 2 tỉ lệ; ≥25/30 ca có nhãn do người hành nghề y ký nhận .
G-3 . Đội tự đặt ngưỡng, tự đo, tự báo cáo — không ai ngoài kiểm; đúng điểm yếu nhóm đã tự nêu ở Day 26	Đặt nhịp review 20 phút mỗi thứ Sáu 20h , mỗi buổi có đúng một người ngoài đội dự (mentor tuần lẻ, cố vấn tài chính tuần chẵn); biên bản 5 dòng đẩy lên repo ngay sau buổi.	Trần Vương Hưng = A của T2 và T5 trong RACI	Buổi đầu 05/09 Đủ 4 buổi trước 28/09/2026	4 file biên bản trong docs/weekly/, mỗi file có ngày, tên người ngoài đội đã dự và đúng 1 quyết định được chốt trong buổi.

KIỂM TRA TÍNH NHẤT QUÁN GIỮA 4 TRANG

Trang 1 → Trang 2: S1 là stakeholder ưu tiên số 1 của Trang 1, là đối tượng của Pitch, và là cột thật trong RACI; S5 và S4 cũng vậy. • **Trang 3 → Trang 4**: gap **G-1 (chuyên môn lâm sàng, Partner)** chính là nguyên nhân của chênh lệch điểm "chất lượng AI", và được xử lý bằng hành động **G-2** của Growth Plan; gap **G-3 (evals)** nói rõ phần lõi năng nội bộ và trỏ thẳng sang Growth Plan. • **Trang 2 → Trang 4**: ba owner của Growth Plan là **đúng ba người đang giữ chữ A** trong RACI cho phần việc tương ứng — không giao việc cho người không chịu trách nhiệm. • **Trang 4 → Trang 1**: hành động G-2 (mời điều dưỡng trưởng chốt nhãn, trả công theo buổi) chính là chiến lược thuyết phục S3 ở Trang 1 — **một hành động, hai mục tiêu**.

4. KỶ LUẬT CỦA KẾ HOẠCH — ĐIỀU BỊ LOẠI BỎ VÀ ĐIỂM KIỂM GIỮA KỲ

BỐN VIỆC ĐÃ BỊ LOẠI KHỎI GROWTH PLAN — VÀ VÌ SAO

Giới hạn 3 hành động buộc nhóm phải bỏ thứ gì đó. Bốn việc dưới đây **bị loại có lý do**, không phải quên:

- "**Tuyển thêm 1 AI Engineer**" — không gỡ được blocker nào của cổng ngày 30, và Trang 3 đã kết luận **không gap nào giải bằng Hire** ở giai đoạn này.
- "**Nội HL7 với HIS bệnh viện**" — thuộc cổng ngày 60. Kéo vào 30 ngày này là tự bắt mình phải xin S4 mở của *trước khi* có bất kỳ con số nào để thuyết phục.
- "**Cải thiện độ chính xác của model**" — chưa đo được thì không biết đang cải thiện cái gì. Việc này chỉ có nghĩa **sau** khi G-2 xong.
- "**Team cần giao tiếp tốt hơn**" — không kiểm được, nên không phải hành động. Hơn nữa tinh thần team đang là điểm **cao nhất (4,3/5)**: đây không phải chỗ đau.

KIỂM GIỮA KỲ NGÀY 14 — 12/09/2026 · NGƯỜI GIỮ NHIP: HƯNG

Kế hoạch 30 ngày thất bại lặng lẽ nếu chỉ kiểm ở ngày cuối. Nhóm chốt trước **ba dấu hiệu thất bại sớm** và phản ứng tương ứng, để khỏi phải tranh luận lúc đang hoảng:

- G-1** — nếu *chưa có ngày bắt đầu shadow được xác nhận* → gửi đề nghị cho **bệnh viện thứ hai ngay trong ngày**, không chờ hết 30 ngày mới thừa nhận là hồng.
- G-2** — nếu *chưa đạt ≥10/30 ca có nhãn được người hành nghề y ký nhận* → **cắt phạm vi xuống 20 golden cases** chứ không bỏ, và tuyệt đối không tự gán nhãn thay người hành nghề cho đủ số.
- G-3** — nếu *đã lỡ một buổi review thứ Sáu* → chuyển sang **thứ Bảy cùng tuần**; dồn hai buổi vào một tức là bỏ một buổi.